

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18^ο

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



«Ο καλός ιατρός θεραπεύει τη νόσο,
ο άριστος ιατρός θεραπεύει τον ασθενή».

William Osler, 1849-1919.

ΟΞΕΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ & ΙΣΧΙΑΛΓΙΑ

Κλινική εξέταση: Χαρακτήρας, εντόπιση, επέκταση και αντανακλάσεις του πόνου.

Το πλήρες ιστορικό του ασθενούς καθώς και η λεπτομερειακή αντικειμενική εξέταση είναι απαραίτητα για τη σωστή αξιολόγηση της οξείας οσφυαλγίας. Κάθε οσφυαλγία αιφνίδιας έναρξης σε ασθενή με ελεύθερο ατομικό ιστορικό, ηλικίας > 60 ετών, πρέπει να διερευνάται διεξοδικά για να αποκλειστούν απειλητικές για την υγεία ή ακόμα και τη ζωή καταστάσεις.

Οι χαρακτήρες της οσφυαλγίας, καθώς και τα συνοδά ευρήματα, που υποδηλώνουν νόσημα που απαιτεί εγρήγορση από μέρους μας και περαιτέρω διερεύνηση, είναι τα κάτωθι:

- * Ηλικία ασθενούς άνω των 60 ετών.
- * Γενικά συμπτώματα, όπως κακουχία/καταβολή, απώλεια βάρους ή πυρετός.
- * Νυχτερινό άλγος που αφυπνίζει τον ασθενή.
- * Φλεγμονώδης οσφυαλγία με πρωινή δυσκαμψία του κορμού.
- * Νευρολογικό έλλειμμα (οι ρίζες που συμπίεζονται πιο συχνά είναι οι Ο5 και Ι1).
- * Εργαστηριακά ευρήματα φλεγμονής (υψηλές τιμές ΤΚΕ, CRP, WBC, φερριτίνης).
- * Αναιμία (αναιμία χρόνιας νόσου, σιδηροπενία, χαμηλή TIBC).

Βάσει των ευρημάτων, οι ασθενείς θα πρέπει να διαχωρίζονται σε 3 αδρές κατηγορίες:

1. Άτομα με απροσδιόριστη οσφυαλγία (χωρίς προφανές αίτιο).
2. Άτομα με συγκεκριμένη παθολογία της ΣΣ (σπονδυλική στένωση ή δισκοπάθεια).
3. Άτομα με κάταγμα ή άλλα συνοδά νοσήματα (π.χ. συμπαγές νεόπλασμα, λέμφωμα, λοίμωξη, αυτοάνοσο νόσημα), τα οποία απαιτούν ξεχωριστή ειδική αντιμετώπιση.

Ιστορικό: Έλεγχος για συνοδά νοσήματα και συνοδά συμπτώματα της οσφυαλγίας, χρόνια λήψη φαρμάκων, παλαιές κακώσεις της ΟΜΣΣ (πτώσεις, λοιμώξεις, ατυχήματα) κ.ά.

Διαφορική Διάγνωση: Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ), πεπτικό έλκος, οστεοπόρωση, κάκωση της ΟΜΣΣ, αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, ψωριασική σπονδυλίτιδα, σύνδρομο Reiter, φλεγμονώδης εντεροπάθεια, Πολλαπλό Μυέλωμα, πρωτοπαθές νεόπλασμα της ΣΣ, νεοπλάσματα της πύελου, μεταστατικό νεόπλασμα προστάτου ή άλλη μεταστατική νόσος, οστεομυελίτιδα, Βρουκέλλωση, φυματιώδης σπονδυλίτιδα (Mal de Pott), νόσος Paget, κ.λπ. Το νωτιαίο επισκληρίδιο απόστημα θα πρέπει να υποπτευθεί ως η αιτία πόνου στη ράχη ή στην οσφύ σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και χρήστες ενδοφλεβίως ναρκωτικών, που παρουσιάζουν τοπική ευαισθησία επί μακρόν, κακουχία και εμμένοντα πυρετό.

Φλεγμονώδης οσφυαλγία: Την οντότητα αυτή υποπτευόμαστε όταν σε ασθενείς με χρόνια εμμένουσα οσφυαλγία (διάρκειας > 3 μηνών) πληρούνται τουλάχιστον 4 από τα παρακάτω 5 κριτήρια, σύμφωνα με τη Διεθνή Εταιρεία Εκτίμησης της Σπονδυλαρθρίτιδας (ASAS):



1. Έναρξη συμπτωμάτων σε ηλικία < 40 ετών.
2. Ύπουλη - υποξεία έναρξη των συμπτωμάτων.
3. Βελτίωση του άλγους με την κίνηση και την άσκηση.
4. Μη βελτίωση του άλγους με την ανάπαυση.
5. Νυχτερινό άλγος που βελτιώνεται με την έγερση.

Ελέγχουμε τυχόν υπάρχουσες ακτινογραφίες οσφύος. Αν δεν υπάρχουν, παραπέμπουμε τον ασθενή για τη διενέργειά τους σε εύλογο χρονικό διάστημα. Επί οσφυαλγίας ύποπτης για συστηματική νόσο, παραπέμπουμε για: PSA/f-PSA, ΤΚΕ, CRP, Ca⁺⁺, ALP, PTH, λεύκωμα Bence-Jones, αντίδραση Wright, αντισώματα Brucella (IgG/IgM/IgA), HLA-B27, κ.λπ.

Όσον αφορά στην **απροσδιόριστη οσφυαλγία**, δεν ενδείκνυνται οι απεικονιστικές μέθοδοι όπως ακτινογραφία ή μαγνητική τομογραφία. Ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης της απροσδιόριστης οσφυαλγίας είναι η ενημέρωση του ασθενούς από τον ιατρό, καθώς και οι γενικές συμβουλές, όπως η άσκηση και η αποφυγή της παρατεταμένης καθήλωσης, ενώ ως φαρμακευτική αγωγή (όπου κριθεί απαραίτητο) προτείνονται η Ακεταμινοφαίνη μόνη ή σε συνδυασμό με ναρκωτικό αναλγητικό (Depon, Panadol, Lonarid-N, Lonalgal, Zaldiar) ή κάποιο ΜΣΑΦ [(κοξίμπες: Dynastat, Arcoxia, Celebrex), Voltaren, Mesulid, Xefo, Vialax].

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Επί οξείας οσφυαλγίας ή/και ισχιαλγίας χορηγείται αναλγησία με Παρακεταμόλη μόνη ή συχνότερα σε συνδυασμό με κάποιο ΜΣΑΦ (iv ή im) κι ένα μυοχαλαρωτικό (im). Ήτοι:
 - 1 fl. 100 ml Combogesic (1 g/300 mg) [iv], και 1 amp. Musco-Ril ή Norflex (im), ή
 - 1 amp. Apotel-plus, μαζί με 1 amp. Dynastat 40 mg (ή *Voltaren, Viaxal, Movatec, Xefo* ή άλλο ΜΣΑΦ), μαζί με 1 amp. Musco-Ril ή Norflex, όλα στην ίδια σύριγγα (im).
2. Σε ασθενείς ηλικίας > 65 ετών ή με ιστορικό ΓΟΠΝ ή γαστροπάθειας, χορηγούμε και γαστροπροστασία, ήτοι: 1-2 amp. Σιμετιδίνη (*Tagamet 200 mg*), im ή iv σε 100 ml N/S. **(Ποτέ όμως στην ίδια σύριγγα με ΜΣΑΦ & Musco-Ril, διότι δημιουργείται ίζημα)!**

Αγωγή κατ' οίκον:

1. Χορήγηση ΜΣΑΦ για 5-10 ημέρες, αναλόγως της βαρύτητας των συμπτωμάτων, ήτοι:
 - tbs. **Mesulid** 100 mg (ή **Xefo** 8 mg) 1x2 για 2-3 ημέρες και 1x1 άλλες 3-4 ημέρες.
2. Χορήγηση αναλγητικών/μυοχαλαρωτικών, για ανακούφιση από το μυϊκό σπασμό, ήτοι:
 - tbs. **Norgesic** 1x4 τις πρώτες 2-3 ημέρες και 1x3 τις επόμενες 4-6 ημέρες.
3. Γαστροπροστασία: **Σιμετιδίνη** (*Tagamet 200 mg*, 1x2), **Φαμοτιδίνη** (*Peptan 20 mg*, 1x2) ή **PPI** (*Pariet 20 mg*, 1x1), επί ενδείξεων και ειδικά σε ασθενείς με βεβαρημένο ιστορικό.
4. Εάν το άλγος ή άλλα συμπτώματα επιμένουν, τότε μπορεί να χορηγηθεί ο συνδυασμός Παρακεταμόλης - Οπιοειδούς αναλγητικού (π.χ. *Κωδεΐνη*⁽¹⁾, *Τραμαδόλη*⁽²⁾) ή συνδυασμός ΜΣΑΦ (*Δεξκετοπροφαίνη*)-Τραμαδόλης⁽³⁾ για μικρό χρονικό διάστημα, όπως παρακάτω:
 - tbs. **Lonarid-N/Nevrine codeine** ή **Lonalgal**⁽¹⁾ 1x1 ή 1x2, για 7-14 ημέρες, ή
 - tbs. **Zaldiar/Algotra**⁽²⁾ (325+37,5) mg, 1x2 για 5-10 ημέρες, ή
 - tbs. **Skudexa**⁽³⁾ (25+75) mg, 1x1, μετά το γεύμα, για 4-7 ημέρες.
5. Σε μακροχρόνιες, εμμένουσες (ανθεκτικές στα κοινά αναλγητικά) και υποτροπιάζουσες περιπτώσεις οσφυαλγίας ή/και ισχιαλγίας - και αφού έχουμε ήδη διερευνήσει για σοβαρά συστηματικά νοσήματα - προτείνεται από πολλούς θεραπεία για βραχύ χρονικό διάστημα με Μεθυλπρεδνιζολόνη (ή *Πρεδνιζολόνη*), ή Πρεγκαμπαλίνη για μεγαλύτερο διάστημα (για το νευροπαθητικό άλγος) ή τέλος με Ντουλοξετίνη (*SSRI*) για μακροχρόνια αγωγή:
 - tbs. **Medrol** 16 mg, 1x2 ή tbs. **Medrol** 4 mg, 2x3, για 7-10 ημέρες.
 - tbs. **Lyrica/Algecia** 50 mg ή 75 mg, 1x2, για 30-60 ημέρες.
 - tbs. **Cymbalta/Onelar** 30 mg ή 60 mg, 1x1 ημερησίως, για 4-6 μήνες.

- ★ Οδηγίες για την αποφυγή άρσης βάρους και για λήψη ανατομικών θέσεων κατά τον ύπνο ή την εργασία, καθώς και για την εκτέλεση ειδικών ασκήσεων για την ενδυνάμωση μυϊκών ομάδων. Επίσης, χρήση θαλπτικών επιθεμάτων (θερμοφόρες, έμπλαστρα) τοπικά, κατά την ανάπαυση. Τέλος, συστήνεται διατροφή για την απώλεια βάρους, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.
- ★ Παραπομπή σε ειδικό, εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή επιδεινώνονται ή εάν η διάγνωση είναι δυσχερής ή αν εμφανίζεται νευρολογικό έλλειμμα. Το νευρολογικό έλλειμμα συχνά εκδηλώνεται ως **σύνδρομο ιππουρίδας** με διαταραχές ούρησης - αφόδευσης, διαταραχές της αισθητικότητας του περινέου (υπαισθησία δίκην σέλας), οπότε απαιτείται η άμεση χειρουργική αποσυμπίεση.

